DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: EVELIA INES GOMEZ GOMEZ **Identificación** CC 65749375
Edad: 65 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 6 **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**489001**	**PERINEOPLASTIA O COLGAJO MAYOR (PIEL MUSCULO) VIA ABIERTA**	Y44	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Vía:

1	**578901**	**CISTOPEXIA (SUSPENSION VESICAL)**	Y43	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Vía:

1	**593101**	**PLICATURA URETRAL**	Y43	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA
Vía: PELVIS

1	**596102**	**PEXIA PARAURETRAL O PERIURETRAL**	Y43	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA
Vía: PELVIS

1	**597940**	**URETROCOLPOPEXIA VIA VAGINAL O ABDOMINAL**	Y41	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA
Vía: PELVIS

1	**674004**	**AMPUTACION DE CUELLO O TRAQUELECTOMIA POR VIA VAGINAL**	Y35	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA
Vía: PELVIS

1	**705110**	**COLPORRAFIA ANTERIOR CON PLASTIA O REPARACION DE URETROCELE**	Y37	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Vía:

1	**705210**	**COLPORRAFIA POSTERIOR**	Y37	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Vía:

1	**707702**	**COLPOPEXIA VIA VAGINAL**	Y41	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Vía:

1	**709203**	**REPARACION DE ENTEROCELE VIA VAGINAL**	Y37	

Cirujano: CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad:** GINECOLOGIA
Vía: PELVIS

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES112 CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ **Especialidad** GINECOLOGIA

489001 **PERINEOPLASTIA O COLGAJO MAYOR (PIEL MUSCULO) VIA ABIERTA**
578901 **CISTOPEXIA (SUSPENSION VESICAL)**
593101 **PLICATURA URETRAL**
596102 **PEXIA PARAURETRAL O PERIURETRAL**
597940 **URETROCOLPOPEXIA VIA VAGINAL O ABDOMINAL**
674004 **AMPUTACION DE CUELLO O TRAQUELECTOMIA POR VIA VAGINAL**
705110 **COLPORRAFIA ANTERIOR CON PLASTIA O REPARACION DE URETROCELE**
705210 **COLPORRAFIA POSTERIOR**
707702 **COLPOPEXIA VIA VAGINAL**
709203 **REPARACION DE ENTEROCELE VIA VAGINAL**

Dx Preoperatorio: N819 PROLAPSO GENITAL FEMENINO NO ESPECIFICADO

Dx Postoperatorio: Z988 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

Tipo de Herida: LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** RAQUIDEA **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 50 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 1
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 10:30:00 **Hora Final** 11:30:00
Tiempo de Perfusión: 1 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 1 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO:
1. COLPORRAFIA ANTERIOR CON PLASTIA DE URETROCELE
2. CORRECCIÓN DE ENTEROCELE VIA VAGINAL
3. PLICATURA URETRAL VIA VAGINAL
4. COLPORRAFIA POSTERIOR CON CORRECCION DE ENTEROCELE
5. PERINEOPLASTIA CON COLGAJO DE PIEL DE GLUTEO VIA VAGINAL
6. COLPOPEXIA VIA VAGINAL
7. CISTOPEXIA VIA VAGINAL
8. PEXIA DE MEATO URETRAL PERIURETRAL.
9. TRAQUELECTOMIA TOTAL (CIRUGIA DE MANCHESTER - FOTHERGILL)
JUSTIFICACIÓN: SE REVALORA CASO: PACIENTE RELATA SENSACION DE MASA EN CANAL VAGINAL, NO ASOCIADO A INCONTINENCIA URINARIA. SE EXPLICA RIESGO DE RECAIDA Y TASA DE CURA DE 80-85%. AL EXAMEN FISICO SE EVIDENCIA PROLAPSO GENITAL DESCRITO ESTADIO IIIC POP-Q , PERO A EXPENSAS DE CERVIX ELONGADO (POP-Q ENCUENTRO EL PUNTO C+1, D-5). DE ACUEROD A ELLO SE INDICA CAMBIO DE CONDUCTA A EXTRAPERITONEAL MEDIANTE SECCION DE CERVIX COMPLETA Y CORRECCION DE PROLAPSOS POSTERIOR Y ANTERIOR + CORRECION DE PROLAPSO URETRAL CON CISTOPEXIA Y PLICATURA PROFILACTICA VERSUS INCONTINENCIA URINARIA OCULTA, PRESENTA EN CERCA DEL 30% DE LOS POSTQUIRURGICOS. ESTE TIPO DE CONDUCTA SE ASOCIA A MENOR MORBIMORTALIDAD. SE REALIZA PERINEOPLASTIA POR DESGARRO OBSTETRICO ANTIGUO PARA EVITAR EL REPROLAPSO MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CUERPO PERINEAL, PREDOMINANTEMENTE DEL COMPARTIMENTO POSTERIOR. CERVIX SANO. SANGRADO 100 CC. ORINA CLARA AL INICIO Y AL FINAL.
DESCRIPCION: PREVIA ANESTESIA REGIONAL. ASEPSIA Y ANTISEPSIA. CATETERISMO VESICAL. PINZAMIENTO DE CERVIX, HIDRODISECCION, COLPOTOMIA EN 360 GRADOS A NIVEL DE ANILLO PERICERVICAL. DISECCION DE CERVIX, LIGAMENTOS CARDINALES-UTEROSACROS DE MANERA ROMA. DOBLE PINZAMIENTO, LIGADURA Y CORTE DE COMPLEJO CARDINAL UTEROSACRO DERECHO CON VICRYL 1. IGUAL PROCEDIEMIENTO CONTRALATERAL. DOBLE PINZAMIENTO, CORTE Y LIGADURA DE PEDICULO UTERINO DERECHO. IGUAL PROCEDIMIENTO CONTRALATERAL. EXERESIS DE LA PIEZA. PUNTOS DE STURMDORF HEMOSTATICOS EN TODO EL LECHO, CONTINUOS. HEMOSTASIA. CATETERISMO VESICAL. SE VERIFICA HEMOSTASIA DE 4 PEDICULOS VASCULARES. SE PASA PUNTO DE MCCALL MODIFICADO A PARED VAGINAL, SEGMENTO UTERINO ANTERIOR, POSTERIOR Y AMBOS COMPLEJOS CARDINAL UTERISACRO Y SE REPARAINCISION EN MUCOSA ANTERIOR A 1 CM DE MEATO URETRAL. DISECCION DE SEPTO PUBO CERVICAL. PASO DE SONDA VESICAL. COLPORRAFIA MEDIANTE CORRECCION DE DEFECTO CENTRAL Y PARAVAGINAL CON PUNTOS DE SITIO ESPECIFICO CON VICRYL 1. PLICATURA URETRAL CON PUNTOS DE KELLY-KENNEDY CON VICRYL 1 (NO. 4) PARAURETRALES DOS A CADA LADO. URETROCOLPOPEXIA CON JARETA DE PUNTOS CON VICRYL1 EN UN SOLO PLANO, FIJO AL ARCO TENDINOSO DE LA FASCIA ENDOPELVICA DERECHA. CISTOPEXIA CON JARETA DE PUNTOS CON VICRYL1 EN UN SOLO PLANO, FIJO AL ARCO TENDINOSO DE LA FASCIA ENDOPELVICA DERECHA. SE REALIZA COLPOPEXIA MEDIANTE APERTURA DE ESPACIO PARARECTAL DERECHO, DISECCION ROMA DE DIAFRAGMA HASTA EXPOSICION DE LIGAMENTO SACROESPINOSO. MEDIANTE PORTA DE DESCHAMPS Y HOOK SE PASA PUNTO DE VICRYL 1 A LIGMENTO A 2.5 CM E LA ESPINA CIATICA. PASO DE PUNTO A PARACOLIUM Y CERVIX LATERAL DERECHO. SE ANUDA Y SE APRECIA ASCENSO UTERINO. HIDRODISECCION DE MUCOSA VAGINAL POSTERIOR. INCISION DE MUCOSA VAGINAL POSTERIOR EN LINEA MEDIA, EXPOSICION DE DEFECTO CENTRAL DE CUERPO PERINEAL. COLPORRAFIA MEDIANTE CORRECCION CON PUNTOS DE SITIO ESPECIFICO DE DEFECTO EXPUESTO A ARCO TENDINOSO DE FASCIA RECTOVAGINAL CON VICRYL 1. RESECCION DE MUCOSA VAGINAL REDUNDANTE. SE REALIZA UNA PEQUEÑA INCISIÓN EN EL SACO. SE IDENTIFICA EL CONTENIDO INTESTINAL Y SE DESPLAZA DE NUEVO AL ABDOMEN. SE COLOCA UNA SUTURA EN JARETA DE SUTURA SINTÉTICA CON VICRYL 1 ALREDEDOR DEL CUELLO DEL SACO DEL ENTEROCELE. SE COLOCA UNA SEGUNDA SUTURA EN JARETA DE SUTURA VICRYL 1 ALREDEDOR DEL CUELLO DEL SACO DEL ENTEROCELE. SE OBSERVA EL MUÑÓN DEL SACO. SE IDENTIFICAN LOS LIGAMENTOS URETROSACROS Y LA PARED RECTAL ANTERIOR. SE COLOCAN TRES JUEGOS DE SUTURAS VICRYL 1 ENTRE LA PARED RECTAL ANTERIOR, EL MUÑÓN DEL SACO DEL ENTEROCELE Y LOS LIGAMENTOS URETROSACROS. CADA SUTURA SE COLOCA PROGRESIVAMENTE MÁS ABAJO EN EL CANAL GENITAL QUE LA ANTERIOR. LAS SUTURAS SE ATAN PROGRESIVAMENTE. SE HACE REONSTRUCCION DE CUERPO PERINEAL MEDIANTE AMPLIACIÓN DE COLGAJO DE PIEL GLUTEA POR SURCO INGUINOCRURAL A 2.5 CM DE LINEA MEDIA. SE REALIZA PEXIA DE TRIGONO DE CUERPO PERINEAL MEDIANTE 3 PUNTOS SEPARADOS DE VICRYL 1. CIERRE DE MUCOSA VAGINAL POSTERIOR CON VICRYL 2-0. INCISION PERIURETRAL, SE REALIZA PEXIA PERIUTRAL CON DOS PUINTOS FIJADOS A PERIOSTIO DEL PUBIS A LADO DERECHO E IZQUIERDO CON VICRYL 2-0. SE VERIFICA REPOSICIONAMIENTO DE MEATO. SE POSICIONA 1 MECHA VAGINAL EN FONDO VAGINAL. NO COMPLICACIONES ADVERTIDAS. TRASLADO A RECUPERACION.

Complicaciones : **SI** [ ] **NO** [X]

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

Hallazgos :

--

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES184	RUBEN DARIO PRADO GRANDA	ANESTESIOLOGO
MG30	LEONARDO INSIGNARES	AYUDANTE



CARLOS ANDRES TREJOS RAMIREZ
Reg. 1116436450
GINECOLOGIA

***** FIN DEL REPORTE *****